Клинические рекомендации

Рак носоглотки

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C11** — Злокачественное новообразование носоглотки
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.08.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/535_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 3

2.3 Клиническая картина 4

2.4 Гистологические варианты 4

2.5 Классификация TNM (8-е издание) 4

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы и анамнез 5

3.3 Риноскопия и пальпация лимфатических узлов 5

3.4 ДНК вируса Эпштейна — Барр в крови 5

3.5 Эндоскопическая эндоназальная ревизия носоглотки 5

3.6 УЗИ лимфатических узлов шеи 6

3.7 МРТ и КТ лицевого отдела черепа и шеи 6

3.8 КТ органов грудной полости и ПЭТ-КТ 6

3.9 Оценка эффективности лечения 6

4. Лечение 6

4.1 Лечение по стадиям 6

4.2 Рецидив или остаточная опухоль после лучевой терапии 7

4.3 Лучевая терапия 7
4.4 Лекарственное лечение 8
4.5 Профилактика и лечение осложнений 9
4.6 Медицинская реабилитация 9
5. Диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации и выписке 11
5.1 Диспансерное наблюдение 11
5.2 Организация медицинской помощи 11
5.3 Показания к выписке 12
6. Источник и актуальность 12
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

1. Основные положения

- Рак носоглотки — злокачественная опухоль, развивающаяся из неороговевающего эпителия носоглотки.
- Начальные проявления в большинстве случаев скрываются под маской ОРВИ, ринофарингита, аденоидных вегетаций; нередко первым признаком становятся увеличенные лимфоузлы шеи.
- Поводом заподозрить опухоль являются затруднение носового дыхания, гнусавость, заложенность или пощёлкивание в ухе, снижение слуха, образование на шее.
- Диагноз подтверждает эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа и носоглотки с биопсией; распространённость оценивают по МРТ (предпочтительно) или КТ лицевого отдела черепа и шеи.
- Основным методом радикального лечения является лучевая или химиолучевая терапия.
- При подозрении на рак носоглотки пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи или первичный онкологический кабинет; тактику лечения определяет онкологический консилиум.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Стенки носоглотки

1. **верхняя** — основная кость, часть затылочной кости;
2. **задняя** — I и II шейные позвонки;
3. **передняя** — хоаны;
4. **боковые** — глоточные отверстия слуховых труб;
5. **нижняя** — твёрдое нёбо.

Оценка эффекта лечения

1. **полный эффект** — отсутствие признаков опухоли по данным лабораторных и инструментальных методов;
2. **частичная регрессия** — сокращение опухолевых очагов более чем на 50% при отсутствии новых;
3. **прогрессирование** — новый очаг и (или) рост первичного или метастатических очагов более чем на 25%.

2.2 Этиология

Этиологические факторы

1. инфицирование вирусом Эпштейна — Барр (ВЭБ);
2. хронические воспалительные процессы, вызывающие гиперплазию и метаплазию слизистой оболочки носоглотки;
3. анатомические особенности некоторых рас: более высокая заболеваемость у народов Юго-Восточной Азии, Африки, Индокитая.

Канцерогенные факторы

1. курение, в том числе пассивное;
2. контакт с асбестом, древесной пылью, продуктами нефтепереработки;
3. ионизирующее излучение;
4. вирус Эпштейна — Барр.

Заболеваемость раком носоглотки в России в 2023 г. составила 0,36 на 100 тыс. населения; у мужчин — 0,53, у женщин — 0,2 на 100 тыс.

2.3 Клиническая картина

Клиническая картина складывается из местных симптомов, признаков регионарного и отдалённого метастазирования, общего опухолевого симптомокомплекса. Начальные проявления в большинстве случаев маскируются под ОРВИ, ринофарингит, аденоидные вегетации; нередко к врачу заставляют обратиться увеличенные лимфоузлы шеи.

На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно; симптомы зависят от локализации опухоли и направления её роста.

Первичные симптомы

1. прогрессирующее затруднение носового дыхания, гнусавость;
2. пощёлкивание или заложенность уха, снижение слуха, боль в ухе;
3. головная боль, кровотечения;
4. экзофтальм, птоз, косоглазие;
5. тризм жевательной мускулатуры, расстройство глотания и фонации;
6. провисание мягкого нёба, неподвижность половины гортани, отклонение языка в сторону;
7. образования на шее.

2.4 Гистологические варианты

Среди злокачественных опухолей носоглотки преобладают эпителиальные; рак составляет около 70%.

Гистологические варианты рака носоглотки

1. плоскоклеточный ороговевающий рак;
2. плоскоклеточный неороговевающий рак (дифференцированный и недифференцированный);
3. базалоидный вариант плоскоклеточного рака.

2.5 Классификация TNM (8-е издание)

Символ T

T	Первичная опухоль
T0	первичная опухоль не определяется, но имеется поражение регионарных лимфоузлов, связанное с ВЭБ
Tis	преинвазивная карцинома
T1	в пределах носоглотки или с распространением в ротоглотку или полость носа без распространения в парафарингеальное пространство
T2	распространение в парафарингеальное пространство
T3	распространение на основание черепа и (или) придаточные пазухи носа
T4	интракраниальное распространение и (или) поражение черепных нервов, распространение в орбиту, подвисочную ямку, жевательное пространство

1. **N1** — метастазы в шейных лимфоузлах выше надключичной ямки на стороне поражения не более 6 см и (или) одно- или двусторонние ретрофарингеальные не более 6 см;
2. **N2** — двусторонние метастазы в шейных лимфоузлах выше надключичной ямки до 6 см;
3. **N3** — метастазы более 6 см и (или) ниже нижнего края перстневидного хряща.

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
0 / I / II / III	TisN0 / T1N0 / T0–T1N1, T2N0–N1 / T0–T2N2, T3N0–N2
IVA / IVB / IVC	T4N0–N2 / любая T N3 / M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнестических данных;
2. клинической картины и осмотра с пальпацией регионарных лимфоузлов;
3. цитологического исследования отделяемого верхних дыхательных путей, отпечатков, пунктата увеличенных лимфоузлов;
4. патологоанатомического исследования биопсийного материала;
5. инструментального обследования: фиброларингоскопия, КТ или МРТ, ПЭТ-КТ по показаниям;
6. определения ДНК вируса Эпштейна — Барр.

3.2 Жалобы и анамнез

При подозрении на рак носоглотки необходим тщательный сбор жалоб и анамнеза; стаж курения оценивают в пачка-летах.

Факторы риска

1. курение, употребление крепких спиртных напитков;
2. производственные вредности;
3. хроническая инфекция: хронический фарингит, отит, ринит, вирус Эпштейна — Барр.

3.3 Риноскопия и пальпация лимфатических узлов

Физикальное обследование при подозрении на рак носоглотки включает

1. переднюю и заднюю риноскопию;
2. пальпацию регионарных лимфоузлов;
3. оценку нутритивного статуса.

3.4 ДНК вируса Эпштейна — Барр в крови

Количественное определение ДНК ВЭБ методом ПЦР в периферической крови выполняют при раке носоглотки или подозрении на него для верификации опухоли и оценки эффекта лечения.

ДНК ВЭБ методом ПЦР в реальном времени выявлена у 96% пациентов с раком носоглотки и у 7% здоровых. Высокий исходный или сохраняющийся к концу ЛТ уровень ДНК ВЭБ связан с неблагоприятным прогнозом.

3.5 Эндоскопическая эндоназальная ревизия носоглотки

Диагноз подтверждается эндоскопической эндоназальной ревизией полости носа и носоглотки с биопсией, мазками-отпечатками с поверхности эрозий и изъязвлений, пункцией уплотнений без изъязвления.

3.6 УЗИ лимфатических узлов шеи

УЗИ лимфоузлов шеи с обеих сторон выполняют каждому пациенту, подозрительные узлы пунктируют для цитологического и патологоанатомического исследования.

При подозрении на метастазы в лимфоузлах шеи показано цитологическое исследование материала тонкоигольной аспирационной биопсии под контролем УЗИ.

3.7 МРТ и КТ лицевого отдела черепа и шеи

Распространённость опухоли оценивают по КТ лицевого отдела черепа с болюсным контрастированием и (или) МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием. Предпочтительна МРТ; КТ дополняет её при опухоли у основания черепа для оценки костной деструкции.

Зона исследования шеи: от основания черепа до верхней апертуры грудной клетки, при поражении лимфоузлов ниже перстневидного хряща — до бифуркации трахеи. При большом интракраниальном компоненте дополнительно выполняют МРТ головного мозга.

Для планирования ЛТ выполняют МРТ лицевого отдела черепа с контрастированием, для оценки распространения на кости основания черепа КТ с болюсным контрастированием. При невозможности МРТ выполняют КТ или ПЭТ-КТ.

3.8 КТ органов грудной полости и ПЭТ-КТ

Стадирование

1. КТ органов грудной полости, при невозможности прицельная рентгенография органов грудной клетки;
2. ПЭТ-КТ с ФДГ при местно-распространённом процессе и метастазах в регионарных лимфоузлах для поиска отдалённых метастазов.

3.9 Оценка эффективности лечения

Через **2–3 месяца** после ЛТ или ХЛТ всем пациентам выполняют МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием; при неоднозначном результате показана ПЭТ-КТ для отличия постлучевых изменений от рецидива.

При регионарных метастазах ПЭТ-КТ с ФДГ выполняют **не ранее чем через 3 месяца** после ЛТ или ХЛТ для решения вопроса о шейной лимфодиссекции.

Через **2–3 месяца** после ЛТ или ХЛТ подозрительные лимфоузлы шеи пунктируют под контролем УЗИ, чтобы подтвердить полную резорбцию метастазов и решить вопрос об отказе от лимфаденэктомии.

Подозрительными считают лимфоузлы шеи I–IV групп **более 2 см**, V группы **более 1 см**, а также узлы с изменённой структурой по данным УЗИ.

---

4. Лечение

Основным методом радикального лечения является лучевая или химиолучевая терапия.

4.1 Лечение по стадиям

Стадия	Тактика лечения
T1N0M0	самостоятельная ЛТ
T2N0M0	самостоятельная ХЛТ
T1N1–3, T2–T4 любая N	одновременная ХЛТ, затем адъювантная ХТ (2 цикла), или индукционная ХТ (3 цикла), затем одновременная ХЛТ

Стадия	Тактика лечения
любая T и N, M1	ХТ с препаратами платины, предпочтительно в сочетании с камрелизумабом в 1-й линии независимо от экспрессии PD-L1 и статуса ВЭБ

При остаточных метастатических лимфоузлах после консервативного лечения целесообразно хирургическое лечение; при полной регрессии узлов — динамическое наблюдение.

После ХЛТ при местно-распространённом раке III–IVA стадии (кроме T3–4N0 и T3N1) может быть рассмотрена адъювантная ХТ #капецитабином 650 мг/м² 2 раза в сутки в течение 1 года, начатая не позднее 12–16 недель после ХЛТ.

Изучен и другой режим адъювантного #капецитабина после ХЛТ: 1,0 г/м² в 1–14-й дни, затем неделя перерыва, 8 курсов (кратность приёма в тексте КР пропущена).

Индукция по схеме DCF (доцетаксел, цисплатин, фторурацил) с последующей ХЛТ при T3–4N+ улучшает 3-летнюю безрецидивную и общую выживаемость по сравнению с одновременной ХЛТ.

4.2 Рецидив или остаточная опухоль после лучевой терапии

В 1-й линии применяют ХТ с препаратами платины, предпочтительно в сочетании с камрелизумабом. При резектабельной опухоли обсуждают операцию и повторную ЛТ или ХЛТ, при нерезектабельной — повторную ЛТ или ХЛТ, лекарственную терапию либо симптоматическое лечение.

Повторная ЛТ обсуждается при общем состоянии ECOG 0–1 и **не ранее 6 месяцев** (предпочтительно **не ранее 2 лет**) после предшествующего облучения.

Рецидив или остаточная опухоль с отдалёнными метастазами

1. **ECOG 0–1**: лекарственное лечение (полихимиотерапия, монохимиотерапия или иммунотерапия) с учётом первичного лечения;
2. **ECOG 2**: монохимиотерапия или симптоматическое лечение;
3. **ECOG 3**: симптоматическое лечение.

4.3 Лучевая терапия

При самостоятельной ЛТ на первичный очаг подводят 66–70 Гр (1,8–2,2 Гр за фракцию), на локорегионарную область с лимфоузлами — 50 Гр (2,0 Гр за фракцию) или 54–63 Гр (1,6–1,8 Гр за фракцию).

При одновременной ХЛТ на первичный очаг и регионарные метастазы подводят 70 Гр (2,0 Гр за фракцию) ежедневно с понедельника по пятницу **в течение 7 недель**, на локорегионарную область — 50 Гр или 54–63 Гр.

Паллиативную ЛТ применяют для облегчения или профилактики локорегионарных симптомов при невозможности радикального лечения, в том числе 50 Гр (2,5 Гр за фракцию) или 30 Гр (3 Гр за фракцию).

ЛТ проводят в специализированных учреждениях с опытом лечения рака носоглотки. Предпочтительны высокопрецизионные методы (IMRT, VMAT), при значительных ограничениях дозы на нормальные ткани — протонная терапия; допустима 3D-конформная ЛТ.

До лечения пациента оценивает радиотерапевт. Объём облучения до радикальных доз не изменяют по ответу на индукционную ПХТ, кроме случаев прогрессии; при быстрых анатомических изменениях (уменьшение опухоли, потеря массы тела) возможно повторное планирование.

4.4 Лекарственное лечение

При одновременной ХЛТ применяют цисплатин 100 мг/м² на фоне гипергидратации в 1, 22 и 43-й дни ЛТ (суммарно 300 мг/м²). После индукционной ПХТ альтернативой цисплатину является карбоплатин AUC 1,5–2,0 еженедельно с первого дня ЛТ.

Схемы индукционной ХТ

1. доцетаксел 75 мг/м² и цисплатин 75 мг/м² в 1-й день, фторурацил 1000 мг/м²/сут 96-часовой инфузией в 1–4-й дни; 3 цикла с интервалом 3 недели;
2. #гемцитабин 1000 мг/м² в 1-й и 8-й дни и цисплатин 80 мг/м² в 1-й день каждые 3 недели; 3 цикла;
3. #гемцитабин 1000 мг/м² и цисплатин 40 мг/м² в 1-й и 8-й дни каждые 3 недели; 3 цикла.

При ХЛТ с последующей адъювантной ХТ цисплатин вводят в дозе 100 мг/м² 1 раз в 3 недели или 40 мг/м² еженедельно на фоне ЛТ.

Схемы адъювантной ХТ

1. цисплатин 80 мг/м² в 1-й день и фторурацил 1000 мг/м²/сут в 1–4-й дни каждые 4 недели, 3 цикла; при невозможности введения цисплатина — карбоплатин;
2. #гемцитабин 1000 мг/м² в 1-й и 8-й дни и цисплатин 80 мг/м² в 1-й день каждые 4 недели, 3 цикла;
3. #гемцитабин 1000 мг/м² и цисплатин 30 мг/м² в 1-й и 8-й дни каждые 3 недели, 3 цикла;
4. #капецитабин 650 мг/м² внутрь 2 раза в сутки в течение года.

При рецидиве и отдалённых метастазах в 1-й линии применяют камрелизумаб 200 мг в 1-й день, #гемцитабин 1000 мг/м² в 1-й и 8-й дни, цисплатин 80 мг/м² в 1-й день; курс 21 день, 4–6 курсов, далее камрелизумаб 200 мг каждые 3 недели до прогрессирования или непереносимой токсичности.

При невозможности химиоиммунотерапии проводят комбинированную ХТ или монохимиотерапию; число курсов определяется переносимостью и эффективностью.

Режимы комбинированной ХТ

1. карбоплатин AUC 5–6 + #паклитаксел 175 мг/м² в 1-й день, курс 21 день;
2. цисплатин 75 мг/м² + #доцетаксел 75–100 мг/м² в 1-й день, курс 21 день;
3. цисплатин 100 мг/м² в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м²/сут 96-часовой инфузией в 1–4-й дни, курс 21 день;
4. карбоплатин AUC 5 в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м² 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели;
5. #гемцитабин 1000 мг/м² в 1-й и 8-й дни + цисплатин 80 мг/м² в 1-й день каждые 3 недели.

Режимы монохимиотерапии

1. цисплатин 100 мг/м², курс 21 день;
2. #паклитаксел 80 мг/м² еженедельно;
3. #доцетаксел 100 мг/м² в 1-й день, курс 21 день;
4. фторурацил 1000 мг/м² в 1–4-й дни, курс 21 день;
5. #метотрексат 40 мг/м² 1 раз в неделю;
6. #капецитабин 1250 мг/м² внутрь 2 раза в день в 1–14-й дни, перерыв 1 неделя, курс 21 день;
7. #гемцитабин 1000 мг/м² в 1, 8 и 15-й дни 1 раз в 28 дней.

Во 2-й линии применяют один из этих режимов, пембролизумаб при MSI или CPS более 1 либо ниволумаб, если 1-я линия не содержала камрелизумаб.

4.5 Профилактика и лечение осложнений

При угрозе или состоявшемся кровотечении из опухоли или метастатических узлов выполняют ангиографию наружной сонной артерии и при отсутствии противопоказаний селективную и суперселективную эмболизацию сосудов опухоли.

При оценке риска кровотечения учитывают:

1. размеры опухоли и переход на соседние структуры;
2. изъязвление опухоли;
3. полость в области опухоли или рецидива;
4. близость к ветвям сонной артерии;
5. незаживающую рану;
6. состоявшееся кровотечение из опухоли.

На фоне противоопухолевой лекарственной терапии проводят профилактику и лечение осложнений по КР Российского общества клинической онкологии

1. тошнота и рвота;
2. фебрильная нейтропения и инфекционные осложнения;
3. гепатотоксичность;
4. сердечно-сосудистые осложнения;
5. кожные реакции;
6. нефротоксичность;
7. иммуноопосредованные нежелательные явления;
8. мукозиты;
9. анемия;
10. синдром анорексии-кахексии;
11. экстравазация противоопухолевых препаратов;
12. хронический болевой синдром;
13. инфузионные реакции;
14. реактивация или обострение хронических вирусных гепатитов;
15. неврологические осложнения.

Уровни убедительности по отдельным осложнениям в КР различаются (от А до С).

При длительных (свыше 6 часов) инфузиях фторурацила или неудовлетворительном состоянии периферических вен рекомендуется установка порта в центральную вену и инфузионных помп.

4.6 Медицинская реабилитация

До начала лечения проводят профилактическую гимнастику и обучение тактике глотания, чтобы уменьшить нарушения глотания на фоне противоопухолевой терапии.

Перед ЛТ или ХЛТ пациента осматривает стоматолог, который сопровождает его на всех этапах лечения и реабилитации.

В постлучевом периоде облучённые ткани очень ранимы: в ранние сроки инвазивные диагностические процедуры и биопсию без крайней необходимости не выполняют.

Удаление зубов в зоне облучения является частой причиной лучевого остеомиелита, поэтому по возможности ограничиваются консервативными методами, а удаление выполняют только при необходимости, на фоне антибиотикотерапии.

Нутритивно-метаболическую реабилитацию перед операцией проводят **не менее 7 суток**.

Показания к нутритивной поддержке при планировании хирургического лечения

1. непреднамеренная потеря **10% массы тела и более** за 6 месяцев;
2. индекс массы тела **менее 20 кг/м²**;
3. гипопротеинемия **менее 60 г/л** или гипоальбуминемия **менее 30 г/л**;
4. ухудшение возможности приёма пищи за последнюю неделю.

Показания к нутритивной поддержке при химиотерапии

1. индекс массы тела **менее 20 кг/м²**;
2. потеря **более 5% массы тела** за 6 месяцев;
3. гипопротеинемия **менее 60 г/л** или гипоальбуминемия **менее 30 г/л**;
4. невозможность адекватного питания через рот;
5. энтеропатия средней и тяжёлой степени.

Лучевой дерматит

1. **профилактика**: низкоинтенсивное лазерное облучение кожи, начиная **через 3 дня** после начала ЛТ, 3 дня в неделю;
2. **лечение**: с появления дерматита до полного стихания реакции дерматопротекторы и ранозаживляющие местные средства (гели, мази).

При болевом синдроме, вызванном лучевыми повреждениями, назначают местные анестетики и системные анальгетики, при необходимости опиоиды, в том числе трансдермальные.

Обезболивание при раке носоглотки проводят по КР «Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи».

При ЛТ или ХЛТ регулярно контролируют нутритивный статус по шкалам MUST, NRS 2002 и корригируют его специализированным питанием.

При высоком риске нарушения питания (например, ХЛТ при местно-распространённом раке глотки) рассматривают профилактическую нутритивную поддержку.

Энтеральное питание начинают, если питание через рот покрывает менее 60% потребности **в течение 10 дней**; потеря более 10% исходной массы тела также является показанием. Предпочтителен сиппинг высокобелковыми смесями; при невозможности — назогастральный зонд (при сроке стояния **до 3–4 недель**) или гастростомия. Белок — не менее 1,2–2 г/кг/сут, энергия — 25–30 ккал/кг/сут.

При болевом синдроме на фоне ЛТ или ХЛТ показана консультация врача по паллиативной медицинской помощи.

На фоне ХЛТ для профилактики и лечения мукозита полости рта и глотки применяют низкоинтенсивное лазерное излучение на область дёсен.

На фоне химиотерапии рекомендуется раннее начало физических нагрузок для профилактики саркопении, уменьшения слабости и улучшения качества жизни.

Реабилитация на фоне химиотерапии и ХЛТ

1. ЛФК: аэробные упражнения средней интенсивности в сочетании с упражнениями на сопротивление;
2. упражнения на тренировку баланса при полинейропатии;
3. низкоинтенсивная лазеротерапия и переменное магнитное поле при периферической полинейропатии;
4. аппараты для профилактики алопеции;
5. низкоинтенсивное лазерное излучение на область дёсен для профилактики и лечения мукозита полости рта.

5. Диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации и выписке

5.1 Диспансерное наблюдение

Сроки контрольных обследований после лечения

Исследование	Первые 2 года	3–5-й год	После 5 лет
Осмотр и сбор жалоб	1-й год: **каждые 1–3 месяца**; 2-й год: **каждые 2–6 месяцев**	**1 раз в 4–8 месяцев**	ежегодно или при появлении жалоб
Фиброларингоскопия (если адекватный осмотр зоны интереса невозможен)	**каждые 3 месяца**	каждые 4–8 месяцев	1 раз в год
УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон	**каждые 1–3 месяца**	каждые 4–8 месяцев	1 раз в год
КТ или МРТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием	**каждые 1–3 месяца**	каждые 4–8 месяцев	1 раз в год
КТ органов грудной полости (при невозможности прицельная рентгенография)	каждые 6 месяцев	каждые 6 месяцев	1 раз в год

У пациентов с высоким риском рецидива интервалы между обследованиями сокращают.

Объём обследования по разделу 5 КР

1. анамнез и физикальное обследование;
2. КТ или МРТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием;
3. эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа и носоглотки;
4. КТ органов грудной полости **каждые 12 месяцев**;
5. ПЭТ всего тела **не ранее чем через 1 год** после окончания ЛТ;
6. ТТГ в крови **каждые 6–12 месяцев**, если облучали шею.

При появлении жалоб или возобновлении прежних симптомов пациент должен незамедлительно обратиться к врачу, не дожидаясь планового визита.

При симптомах рецидива показана ПЭТ-КТ с ФДГ или КТ органов грудной и брюшной полостей с контрастированием, при их невозможности рентгенография органов грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости.

5.2 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой врач направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи или первичный онкологический кабинет.

Тактику лечения определяет онкологический консилиум с участием онкологов и радиотерапевта.

Показания к госпитализации

1. **экстренная**: осложнения онкологического заболевания или его лечения;
2. **плановая**: сложные интервенционные диагностические вмешательства, специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в круглосуточном или дневном стационаре.

5.3 Показания к выписке

1. завершение курса или этапа лечения при отсутствии осложнений, требующих коррекции в стационаре;
2. отказ пациента или законного представителя от лечения в стационаре при отсутствии осложнений, требующих коррекции в стационаре;
3. несоблюдение предписаний или правил внутреннего распорядка, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих;
4. необходимость перевода в другую медицинскую организацию по профилю.

Факторы прогноза

1. размеры и распространённость первичной опухоли;
2. степень дифференцировки опухоли;
3. метастазы в лимфоузлах шеи (вдвое снижают выживаемость);
4. экстранодальное распространение опухоли.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак носоглотки»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 04.08.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2029 года
Код в рубрикаторе	535_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 3.1 при стадии T2N0M0 рекомендована самостоятельная ХЛТ, а следующий пункт для «T2–T4, любого N» рекомендует ХЛТ с адъювантной или индукционной химиотерапией: стадия T2N0 подпадает под оба пункта.
- Число циклов адъювантной ХТ после ХЛТ в тексте указано по-разному: «2 цикла» в разделе 3.1 и «3 цикла» в схемах раздела 3.3.
- Сроки наблюдения расходятся: в разделе 2.4.3 фиброларингоскопия — «каждые 3 месяца в течение первых двух лет…, каждые 2–6 месяцев в течение 2 лет», КТ органов грудной полости — каждые 6 месяцев до 5 лет; в разделе 5 КТ органов грудной полости — каждые 12 месяцев.